

TEMA 3.7 • ENDOCRINOLOGÍA

Hipotiroidismo Congénito

PERFIL EUNACOM 1.03.2.005

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Hipotiroidismo Congénito

Causas

- Disgenesia tiroidea (más frecuente): agenesia, hipogenesia o ectopia en el conducto tirogloso
- Con o sin alteración de la enzimática de síntesis hormonal

Screening Neonatal

- Cuándo:** entre 48–72 horas de vida (antes puede falso (+) por traspaso materno)
- Examen:** TSH en sangre capilar (taco del talón) junto al PKU (fenilcetonuria)
- Si screening (+): TSH > 15 → confirmar con **TSH + T4 libre** en sangre venosa

Interpretación del confirmatorio

TABLA 3.7.1: TSH VS T4 LIBRE

TSH	T4 LIBRE	DIAGNÓSTICO	CONDUCTA
Normal	Normal	Falso positivo	Observar
↑	Normal	Hipotiroidismo subclínico	Repetir exámenes en 7 días (discutido tratar)
↑	↓	Hipotiroidismo congénito	Tratar de inmediato

Tratamiento

- Levotiroxina: 10–15 mcg/kg/día** (dosis alta ajustada a peso — muy distinto al adulto con 1,6 mcg/kg)
- Iniciar cuanto antes (riesgo de daño neurológico irreversible si se demora)

Clínica

- La mayoría son **asintomáticos al nacimiento** → por eso es tan importante el screening
- Síntomas posibles si no se diagnostica a tiempo:
- Ictericia** tardía de predominio indirecto

- Llanto ronco
- Retraso en la caída del cordón umbilical (> 2 semanas)
- Hernia umbilical
- En formas graves: letargia, hipotonía, piel seca, mixedema, macroglosia, hipotermia

EUNACOM CRITERIOS

Cretinismo: déficit cognitivo crónico por hipotiroidismo congénito no tratado. Es irreversible. El screening precoz existe para prevenirlo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Recién nacido de 3 días con screening neonatal que muestra TSH de 22 mU/L. Se solicitan exámenes confirmatorios: TSH 35 mU/L y T4 libre 0,3 ng/dL. ¿Cuál es la conducta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Hipotiroidismo Congénito. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Causa más frecuente: disgenesia tiroidea (agenesia, hipogenesia, ectopia).
- Screening obligatorio entre 48-72 horas de vida con TSH en sangre, antes del alta hospitalaria.
- Si TSH >15 en screening: confirmar con TSH + T4 libre venosa.
- TSH alta + T4 baja = hipotiroidismo congénito confirmado → tratar inmediatamente con levotiroxina.
- Dosis de levotiroxina en neonato: 10-15 µg/kg (mucho más alta que en adulto: 1,6 µg/kg).
- Mayoría asintomáticos al nacer. Clínica: ictericia tardía indirecta, llanto ronco, retraso caída de cordón, hernia umbilical.
- Sin tratamiento evoluciona a cretinismo (déficit cognitivo irreversible).

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO)

PREGUNTA 1

Recién nacido de 3 días con screening neonatal que muestra TSH de 22 mU/L. Se solicitan exámenes confirmatorios: TSH 35 mU/L y T4 libre 0,3 ng/dL. ¿Cuál es la conducta?

- A) Repetir exámenes en 7 días
- B) Observar y controlar en 1 mes
- C) Iniciar levotiroxina 10-15 µg/kg inmediatamente
- D) Solicitar cintigrafía tiroidea antes de tratar
- E) Iniciar levotiroxina 1,6 µg/kg

RESUMEN: HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO

El hipotiroidismo congénito tiene como causa más frecuente la disgenesia tiroidea (agenesia, hipogenesia o ectopia). El screening se hace entre las 48-72 horas de vida con TSH en sangre (capilar o venosa), antes del alta. Si screening alterado (TSH >15), se confirma con TSH + T4 libre venosa. Si ambos normales: falso positivo. Si TSH alta + T4 libre normal: subclínico (discutible tratar, repetir en 7 días). Si TSH alta + T4 libre baja: confirmado, tratar inmediatamente con levotiroxina 10-15 µg/kg. La mayoría son asintomáticos al nacimiento (por eso es vital el screening). Clínica posible: ictericia tardía de predominio indirecto, llanto ronco, retraso en caída del cordón umbilical (>2 semanas), hernia umbilical. En casos graves: sialorrea, hipotonía, letargia, hipotermia, piel seca, mixedema, macroglosia. A largo plazo evoluciona a déficit cognitivo conocido como cretinismo.